

Cirugía Bariátrica y Oncológica del Tubo Digestivo

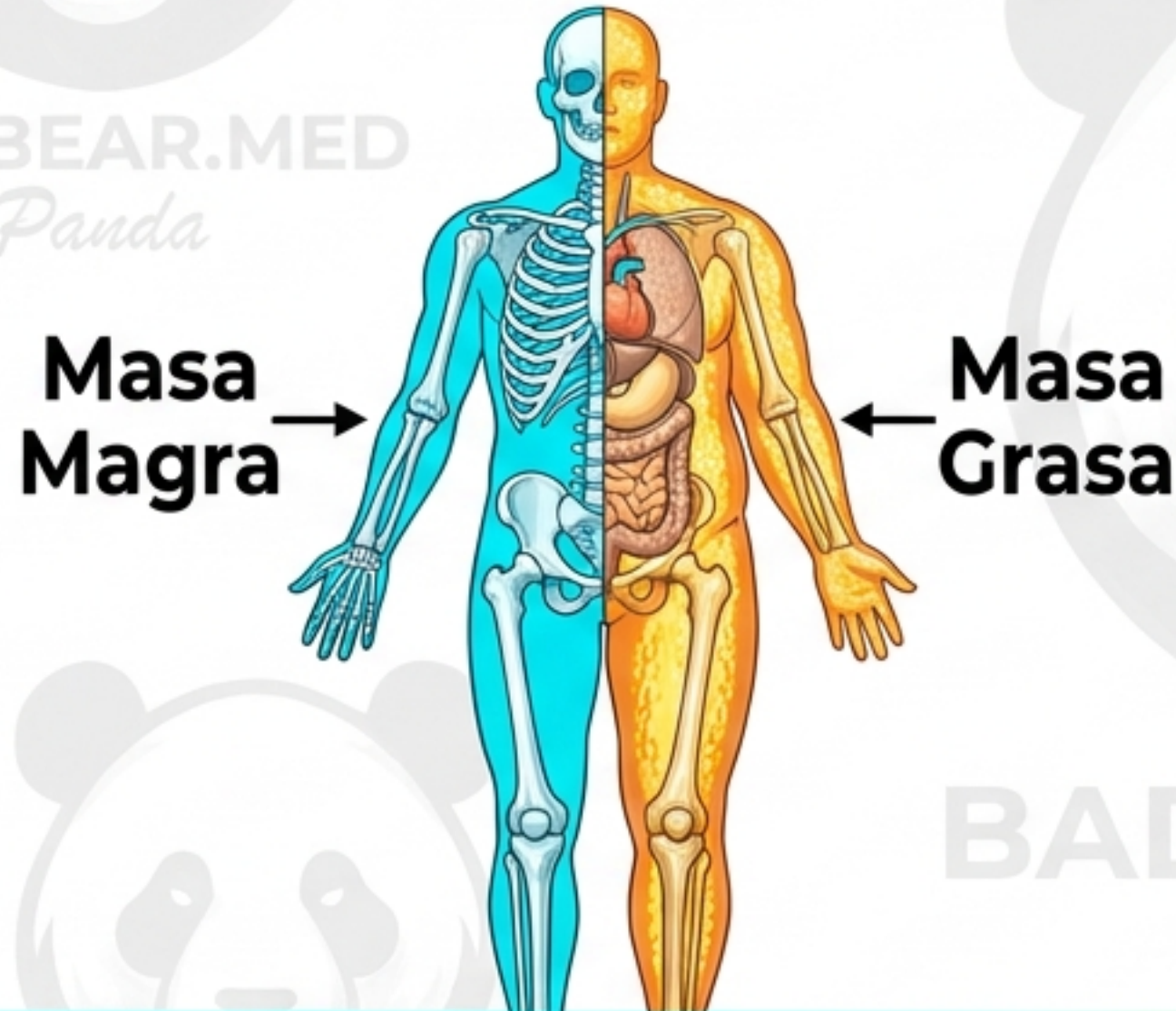
Atlas Clínico y Algoritmos de Intervención Quirúrgica



Proyecto **BADBEAR.MED** | Guía de Estudio Exclusiva

La Obesidad: Definición y Matriz Diagnóstica

Anatomía de la Masa Corporal



Clasificación Clínica (IMC)

Normopeso: 18.5 - 24.9

Sobrepeso (Tipo 1 y 2): 25 - 29.9

Obesidad Tipo 1: 30 - 34.9

Obesidad Tipo 2: 35 - 39.9

Obesidad Tipo 3 (Mórbida): 40 - 49.9

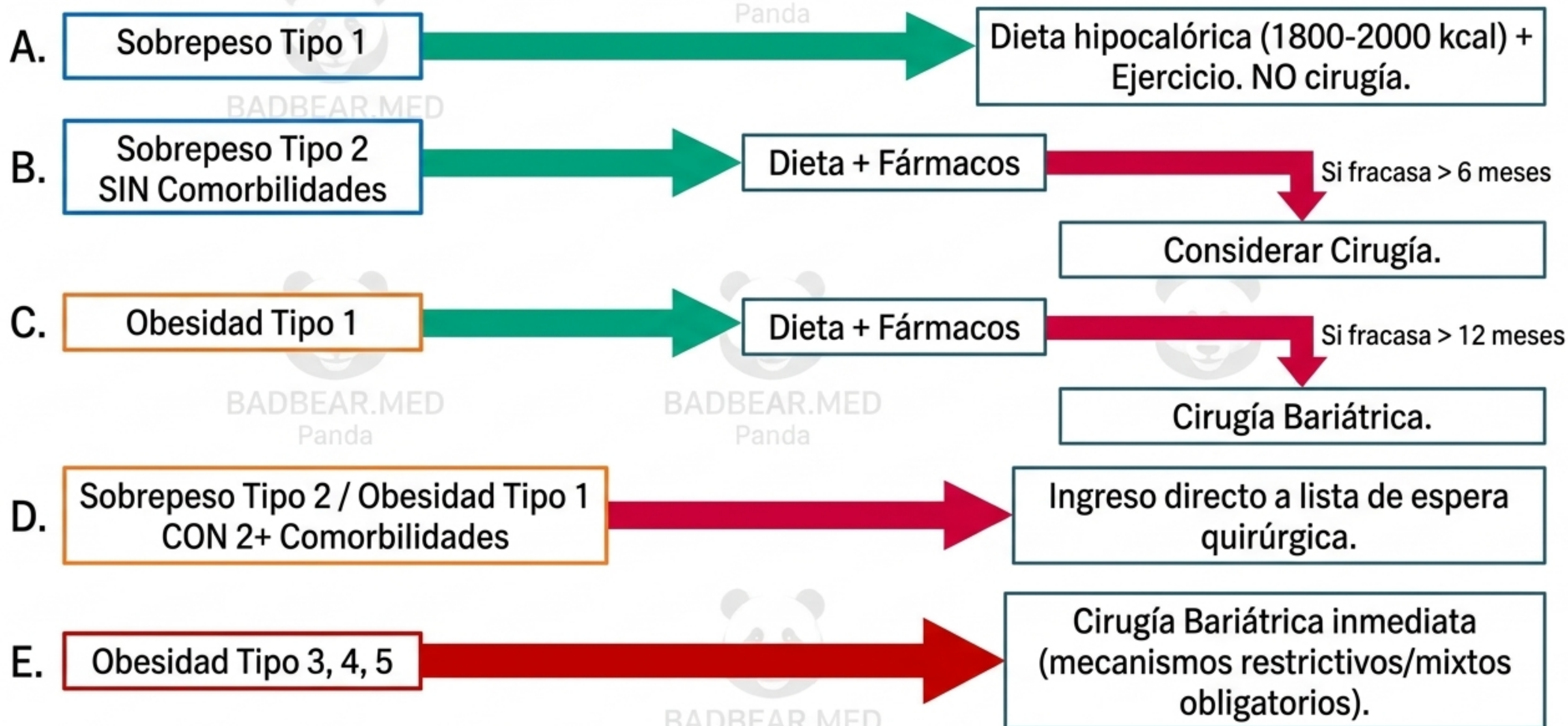
Obesidad Tipo 4 (Extrema): >50

Obesidad Tipo 5 (Súper Extrema): >60

La obesidad es una enfermedad multifactorial proinflamatoria. El exceso de peso patológico es a expensas exclusivamente del tejido adiposo (visceral y corporal).



Algoritmo de Intervención Terapéutica



Farmacoterapia: Puente y Rescate Metabólico

Inhibidores del Apetito 	Inhibidores de Absorción 	Análogos GLP-1 
(Adrenérgicos/Serotoninérgicos): Fentermina, Sibutramina. Actúan en SNC. Efectos secundarios: Taquicardia, rebote severo.	Orlistat. Bloquea la lipasa pancreática (60% de lípidos no se absorben). Efecto secundario: Esteatorrea severa.	(El Estándar Moderno): Liraglutida (diaria), Semaglutida (semanal). Incrementa saciedad y reduce vaciamiento gástrico.

Clinical Pearl

Uso Pre-operatorio del GLP-1: Vital en obesidad extrema para reducir el volumen hepático y la grasa visceral antes de entrar a quirófano, facilitando la técnica quirúrgica.

Protocolo de Ingreso y Descarte Preoperatorio

Checklist Quirúrgico Obligatorio

- ✓ Endoscopia Digestiva Alta obligatoria (Descarte y erradicación de H. pylori para evitar úlceras anastomóticas).
- ✓ Dosaje de Micronutrientes (Vitamina B12, Hierro) pre-existentes.
- ✓ Riesgo Neumológico y reducción hepática por dieta pre-quirúrgica (4-6 semanas).

Contraindicaciones

Absolutas: Embarazo o deseo de embarazo en los próximos 12-18 meses (doble estado hipercatabólico), riesgo cardíaco irreversible (ASA IV), malignidad inoperable.

Relativas: Inestabilidad psicológica, falta de compromiso dietético, adicciones activas.

Taxonomía de la Cirugía Bariátrica

Restrictivas

(Ej. Manga Gástrica).

Reduce la capacidad volumétrica. El estómago deja de ser reservorio y pasa a ser un tubo de tránsito.

Malabsortivas

(Ej. Derivación Biliopancreática).

Desconecta el flujo de alimentos de las enzimas biliares/pancreáticas. Alta desnutrición; hoy en desuso como monoterapia.

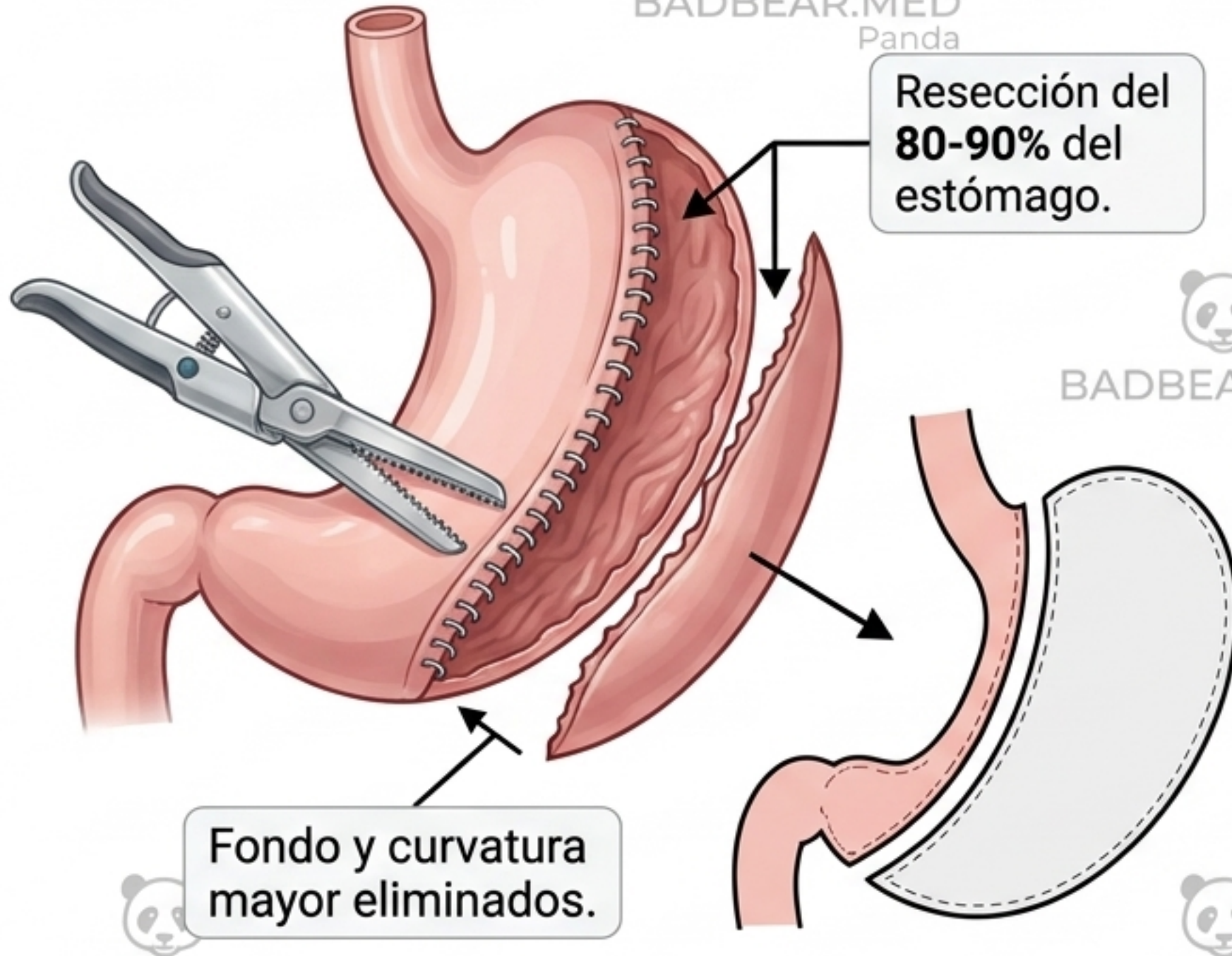
Mixtas

(Ej. Bypass Gástrico en Y de Roux).

Combina restricción volumétrica con malabsorción controlada (50%).

La cirugía bariátrica NO es estética; es una intervención anatómica para forzar la tolerancia a dietas de muy bajo contenido calórico (800-1000 kcal/día).

Manga Gástrica (Sleeve): Anatomía y Endocrinología

BADBEAR.MED
Panda

BADBEAR.MED

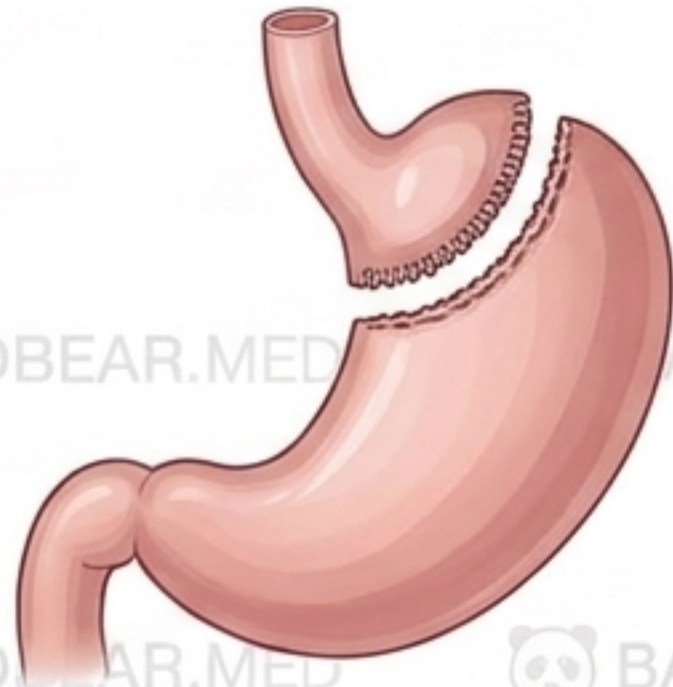
Doble Mecanismo de Acción

1. **Restrictivo:** Volumen drásticamente reducido; llenura rápida.
2. **Hormonal:** Eliminación de los receptores de Grelina (ubicados en el fondo y curvatura mayor), anulando la señal fisiológica del hambre.

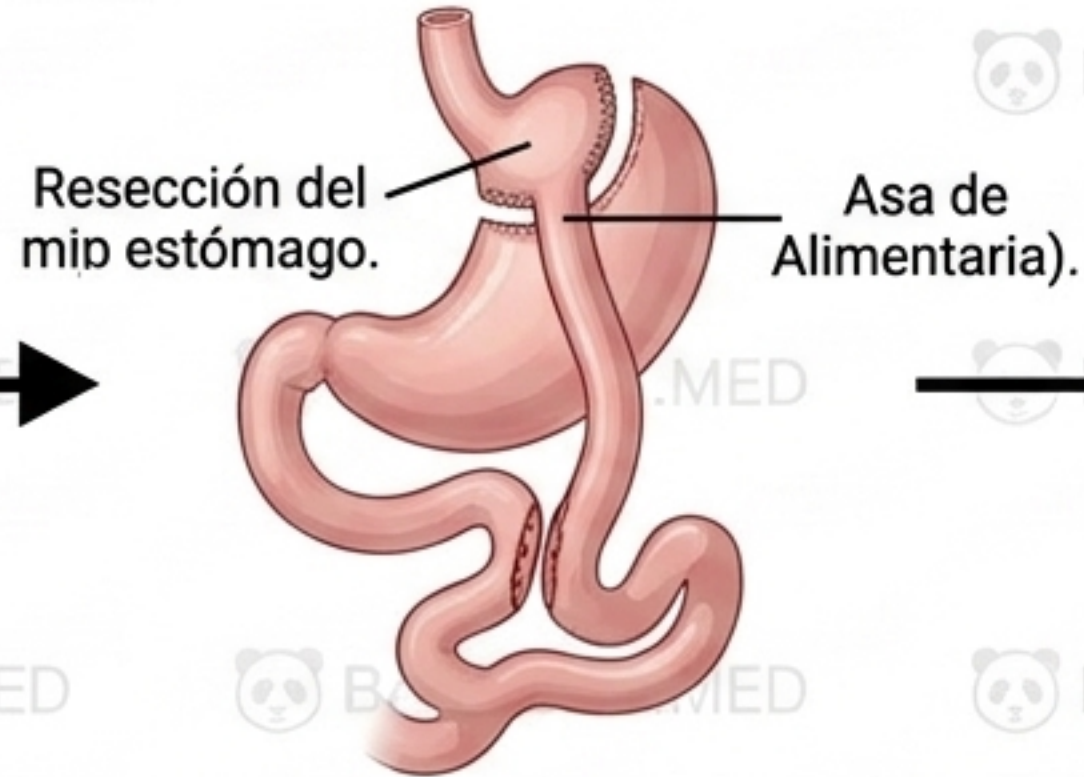
Pérdida promedio de 40-60 kg en un año.

Bypass Gástrico en Y de Roux: El Estándar Metabólico

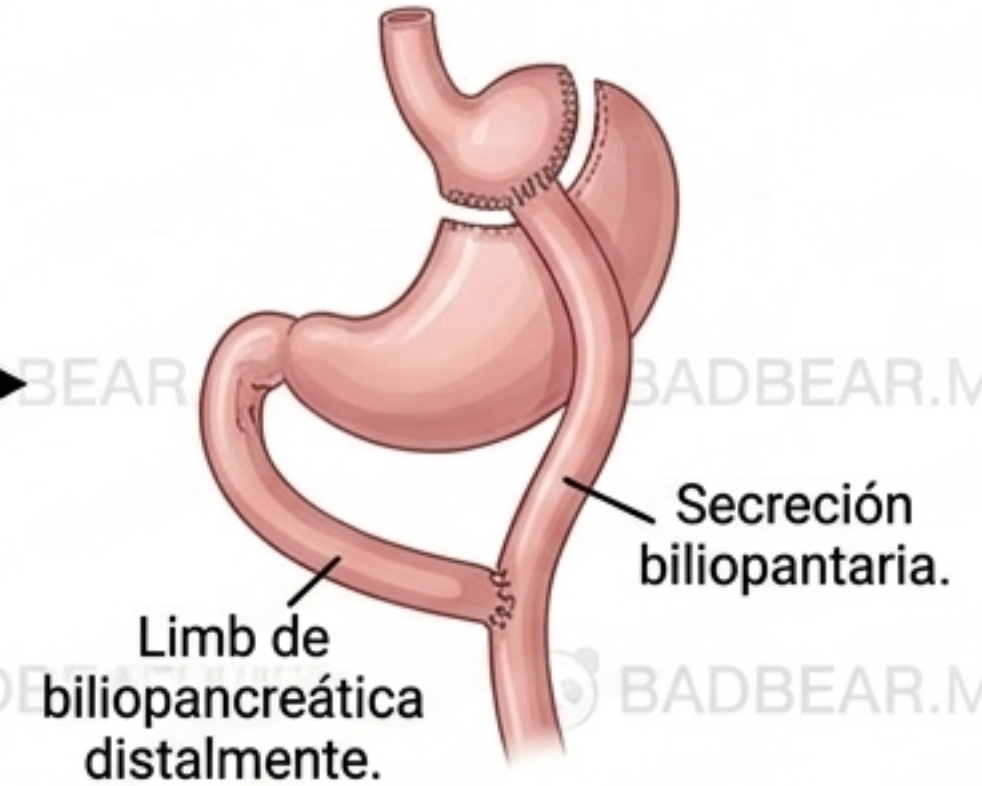
Paso 1: Creación de la micro-bolsa gástrica (reservorio restrictivo).



Paso 2: Subida del asa de yeyuno (Asa Alimentaria).



Paso 3: Anastomosis en Y para unir la secreción biliopancreática distalmente.



Cirugía Metabólica: Al evitar que los alimentos pasen por el **duodeno** y no se mezclen inmediatamente con la insulina y jugos pancreáticos, se revierte drásticamente la **resistencia a la insulina**. **Procedimiento de elección para Diabéticos Tipo 2** y pacientes con **Hernia Hiatal**.

Cirugía Oncológica Gástrica: Principios de Resección

Localización Tumoral

1

Tumor Proximal
(Cardias, Fondo, Cuerpo)



2

Tumor Distal
(Antro, Píloro)



Estrategia de Resección

Gastrectomía Total.
Resección del 100% del órgano.



Gastrectomía Subtotal.
Resección mínima obligatoria
del 80%.



Operabilidad vs. Resecabilidad

- **Operable:** Paciente apto (sin carcinomatosis severa, riesgo quirúrgico aceptable).
- **Resecable:** Hallazgo intraoperatorio donde el tumor puede extraerse con márgenes oncológicos libres sin infiltración retroperitoneal masiva (Márgenes Macroscópicos R0).

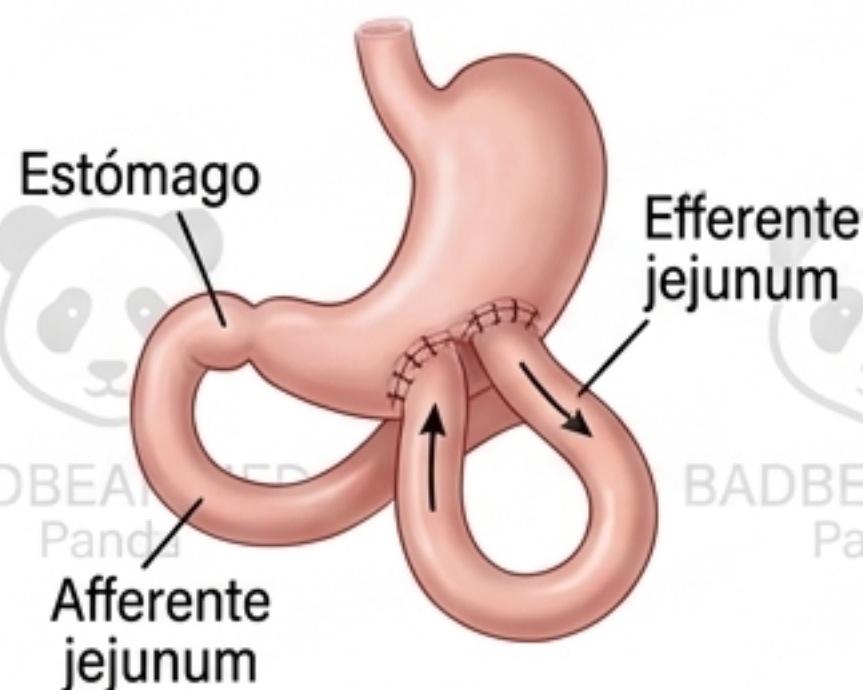
El objetivo oncológico prioriza la resección radical sobre la fisiología digestiva.

Reconstrucción del Tránsito Oncológico

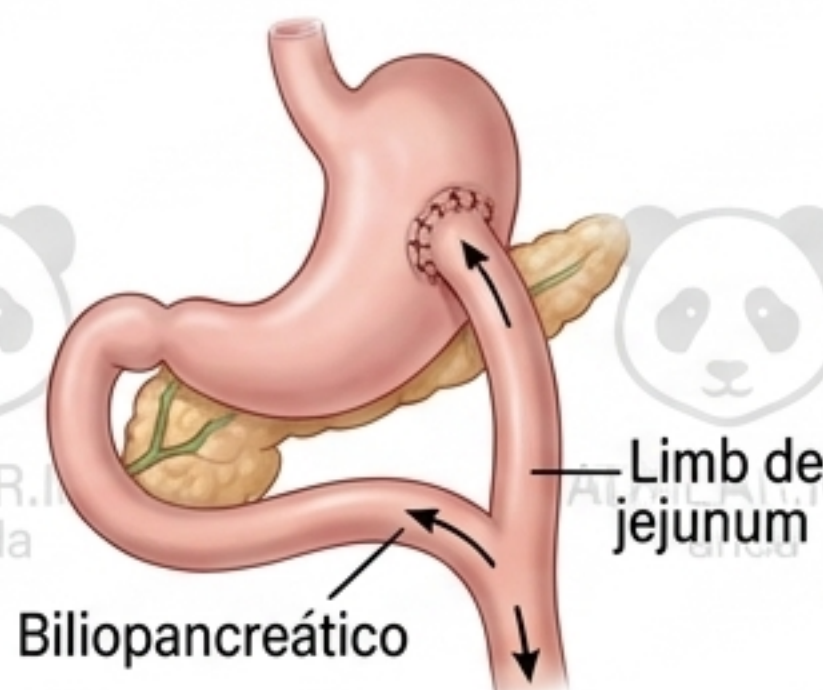
Post-Gastrectomía Subtotal

Billroth II

(Gastro-yeyunostomía en asa)



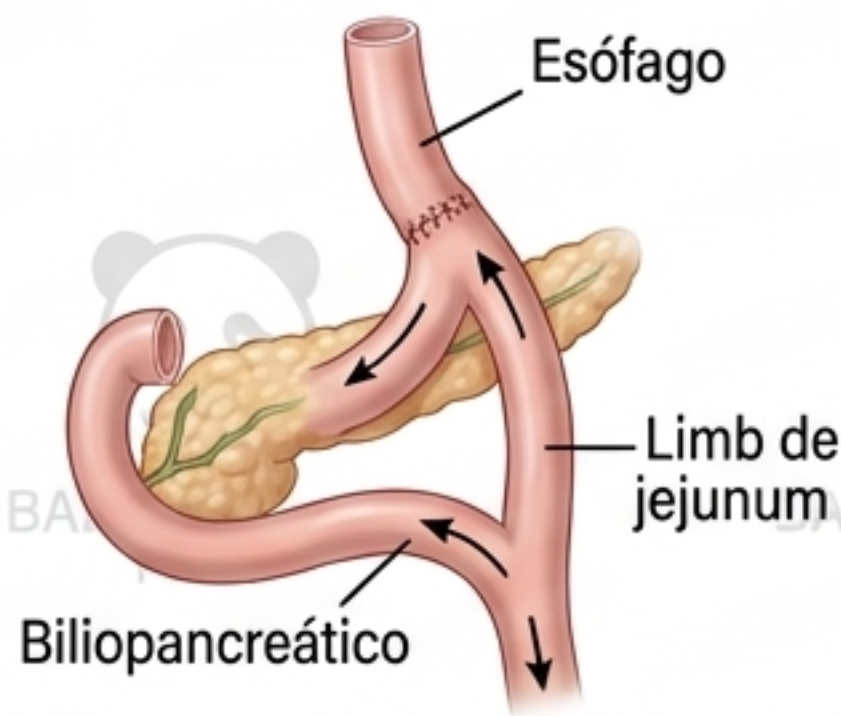
Roux-en-Y



Roux-en-Y previene gastritis alcalina biliar.

Post-Gastrectomía Total

Esófago-yeyunostomía en Y de Roux

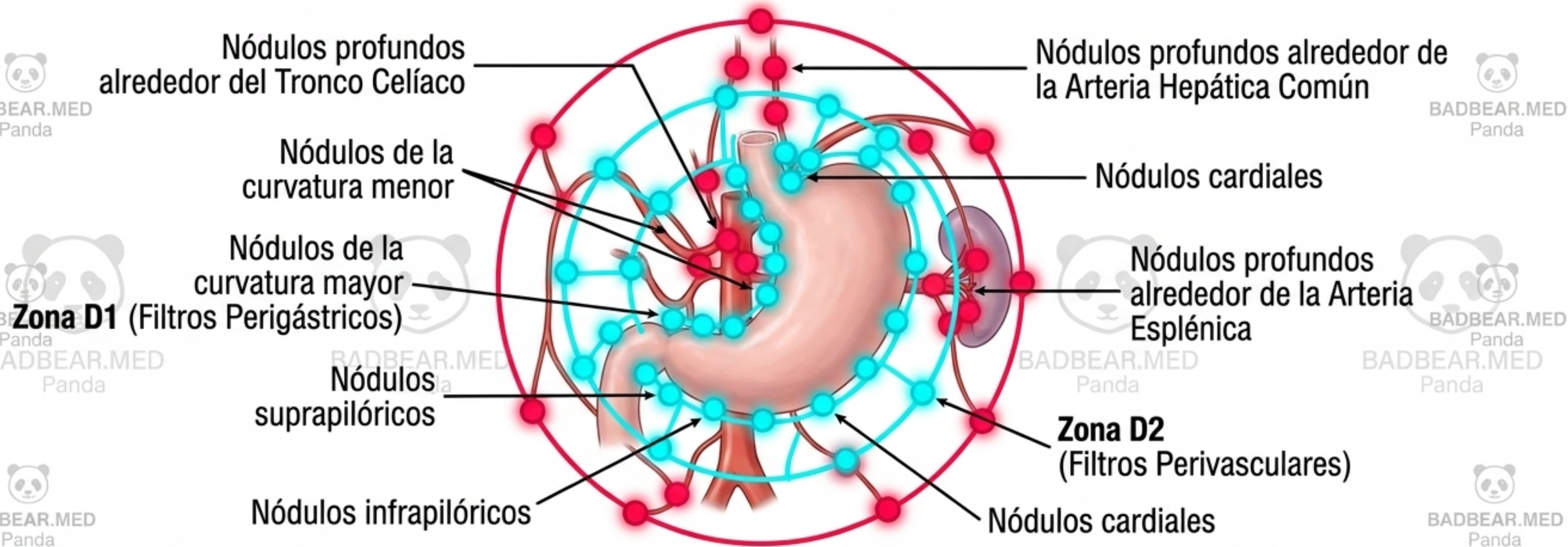


Única reconstrucción viable cuando se remueve el 100% del estómago.

Riesgo Quirúrgico

La anastomosis esófago-yeyunal es de altísimo riesgo debido a la ausencia de capa muscular en el esófago, lo que eleva el riesgo de dehiscencia y fugas anastomóticas. Uso mandatorio de grapadoras circulares mecánicas.

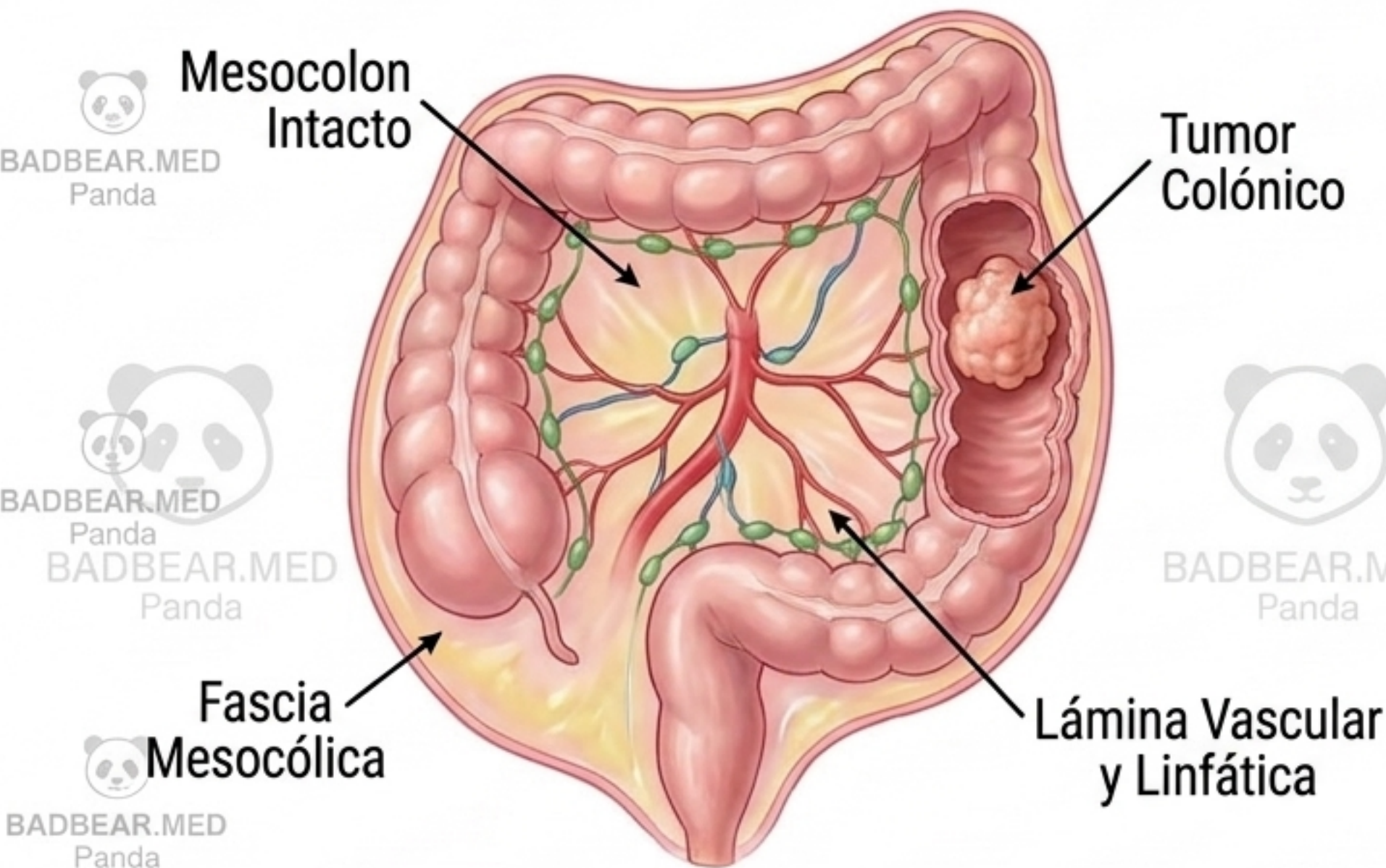
Linfadenectomía Gástrica: El Estándar D2



Regla de Supervivencia

Para lograr intención CURATIVA, es obligatorio realizar una resección D2 (>25 ganglios).
Una resección tipo D1 en cáncer curable se considera automáticamente una cirugía paliativa inaceptable con alto riesgo de recidiva a corto plazo.

Cáncer de Colon: Escisión Mesocólica Completa (CME)



Niveles de Resección Ganglionar Colónica (Los 4 Filtros)

- | | |
|----|--|
| 1. | Epicólicos (en la pared intestinal) |
| 2. | Paracólicos (en la arcada vascular) |
| 3. | Intermedios (trayecto arterial) |
| 4. | Centrales (origen de arterias mesentéricas) |

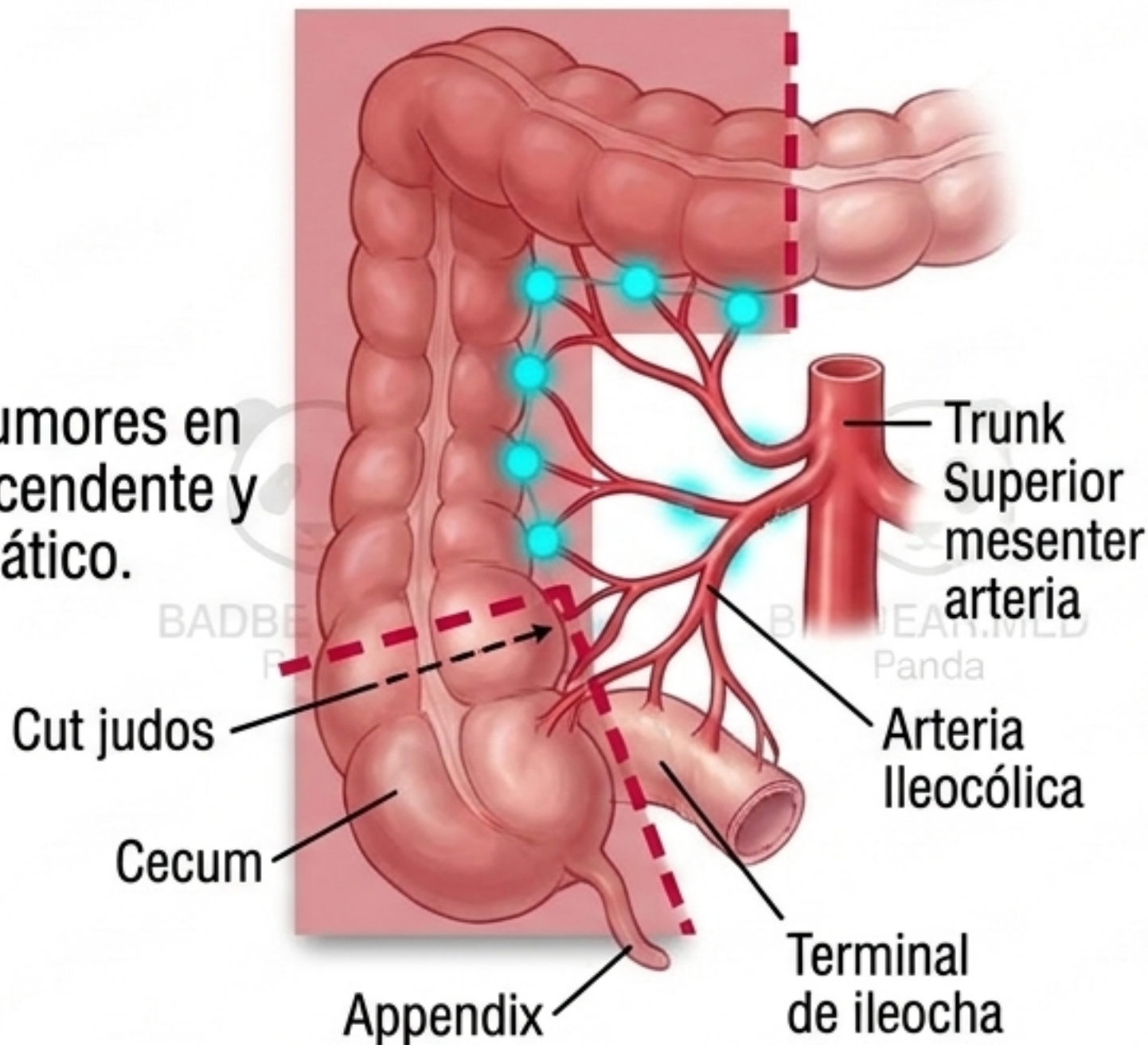
Ligar los vasos en su origen garantiza el barrido de la estación 4.

El Concepto del 'Regalo Envuelto':

El tumor colónico debe extraerse con su lámina de grasa (mesocolon) completamente sellada e intacta. Romper esta fascia derrama células neoplásicas en el peritoneo.

Hemicolectomía Derecha: Control Vascular y Márgenes

Indicaciones: Tumores en ciego, colon ascendente y ángulo hepático.



Checklist de Acción Quirúrgica

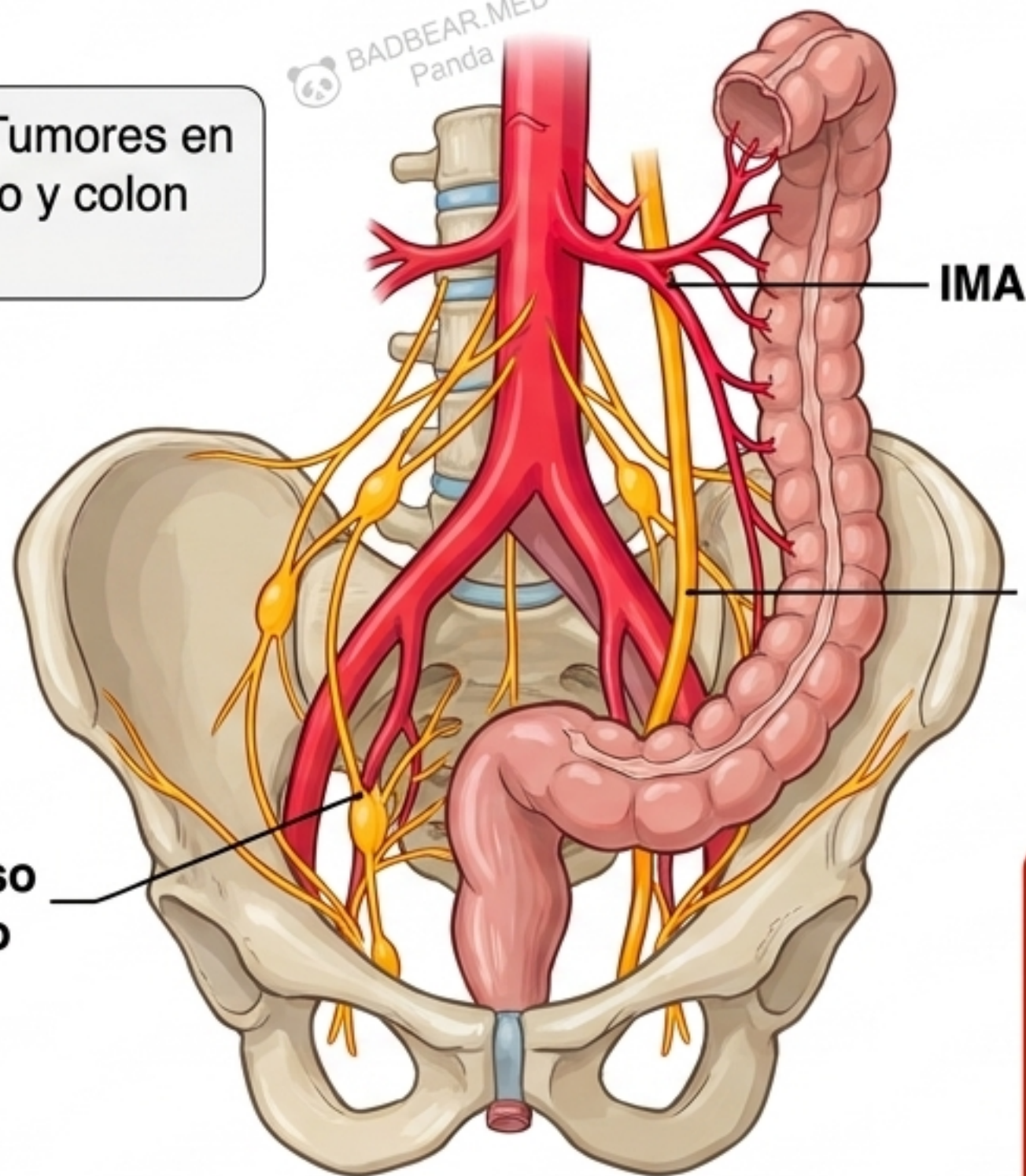
- **Control Vascular (Ligadura Central):** Arteria Ileocólica, Arteria Cólica Derecha, y Rama derecha de la Cólica Media.
- **Márgenes:** 5-10 cm de íleon terminal proximal; tercio proximal/medio del colon transverso distal.
- **Reconstrucción:** Anastomosis Íleo-transversa latero-lateral (asegurando perfusión y ausencia de tensión).

La ligadura vascular central es crucial para una linfadenectomía adecuada y la prevención de recurrencia en el cáncer de colon derecho.



Hemicolectomía Izquierda y Riesgos Anatómicos

Indicaciones: Tumores en ángulo esplénico y colon descendente.



Checklist de Acción Quirúrgica

- **Control Vascular:** Ligadura alta de la Arteria Mesentérica Inferior (raíz aórtica) y Vena Mesentérica Inferior (cerca del páncreas). Liberación del ángulo esplénico.
- **Reconstrucción:** Anastomosis colorrectal.

Zona de Peligro Crítico

Identificación y protección obligatoria del **Uréter Izquierdo** (riesgo de sección inadvertida) y del **Plexo Nervioso Hipogástrico** en el promontorio pélvico (riesgo de disfunción vesical/sexual).

Ecosistema Clínico BADBEAR.MED

Bariátrica

Intervención
metabólica,
restricción calórica,
reversión fisiológica.

Cáncer Gástrico

Resección R0
radical,
Linfadenectomía D2
innegociable.

Cáncer de Colon

Escisión Mesocólica
Completa, ligadura
vascular central,
preservación
nerviosa pélvica.

Síguenos y expande tu dominio clínico en:

Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

(@BADBEAR.MED - El ícono del panda es nuestra firma de excelencia clínica).

